

INDICADO POR: Dr Paulo Cesar
() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

ISMAEL RODRIGUES

IDADE: 73 PESO: 85 ALTURA: 1,75 PROFISSÃO: Mecânico (Aposentado)

SINTOMAS: Engasgos presenciados, sonolência diurna

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Losartana / Torcico / Miti formina 850 / AAS, 100mg
Selegilina

MÉDICO: Drº Paulo Cesar

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 5x academia

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20h

HORA QUE DORME: 21:30 - 22h HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1-2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 3,8 cmH₂O SPO2: 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / DM máscara

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(M) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S (X) N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

07/11/24 Avaliação Auto 5-12 cmH₂O máscara dual Wear
Pillow (M) Natália

14/11/24 P=9,9 cmH₂O P95%=11,3 cmH₂O
IAH=2,7 cmH₂O
m. uso: 4 horas Boca seca P: 5 à 40 cmH₂O
fuga: 41 l/min. Silêncio

21/11/24 P=8,7 cmH₂O P95%=9,9 cmH₂O
IAH=2,2 cmH₂O Sentir Bem adaptado.
m. uso: 7h23min * Deixou máscara fixa: 9,4 cmH₂O
fuga: 34 l/min. não ajustar pillow (MW) Silêncio

12/06/25 P=9 cmH₂O
IAH=3,7 cmH₂O estava colocando ~
m. de uso: 7h30' máscara errada.
fuga=11,9 l/min. Jue

05/12/2024

$P = 9,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,2 \text{ e/h}$
 $m \text{ uso} = 7h44'$
 $fuga = 35 \text{ l/min}$

Boca seca

vai ver pra comprar
CPAP Básico em jato

$P = 9,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,3 \text{ e/h}$
 $M. de uso: 7h40'$

Boca seca

lua claudia

09/01/2025

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,2 \text{ e/h}$
 $m \text{ uso} = 7h40'$
 $fuga = 33$

Bem adaptado / Boca seca

* comprou CPAP Básico *

Silvia

06/02
25

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,3 \text{ e/h}$
 $Fuga = 32,7 \text{ lpm}$
 $M. de uso = 7h44'$

lua claudia

07/04/25

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3,1 \text{ e/h}$
 $m \text{ uso} = 7h19 \text{ min}$
 $fuga = 22 \text{ l/min}$

Bem Adaptado

hao filho

Silvia

Nome: ISMAEL RODRIGUES

Data de Nascimento: 30-4-1951

IMC: 28,41

Sexo: masculino

Data do exame: 11-01-2024

Peso: 88 kg

Altura: 1,76 m

Médico: DRA. CARLA CECILIA MULIN

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 499,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 64,5 e 184,5 minutos. O tempo total de sono foi de 238,0 min, eficiência de 47,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1. 3,6%, estágio N2. 52,9%, estágio N3. 18,1%, sono REM. 25,4%. O índice de despertares foi de 10,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 31,8/hora, sendo 22 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 83 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 83%, permanecendo 1,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 37 - 77 bpm e NREM de 33 - 76 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM ligeiramente aumentada e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 31,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=83%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

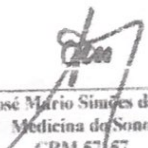
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

12/03/2024, 17:03

Impressão Ampliada



DR Paulo Cesar R. de Carvalho CRM -SP 55350
Pneumologia e Tisiologia / Avaliação Funcional Pulmonar
Título de Especialista em Pneumologia e Tisiologia pela SBPT/AMB desde 1986.
Título de Especialista em medicina intensiva pela AMIB/AMB desde 1996

ISMAEL RODRIGUES

12/03/2024 55350

SPPneumologiaPAULO CESAR RIBEIRO DE CARVALHO Avenida Nove de Julho, 520,
Jardim São Dimas, Sala 26, São José dos Campos - SP

Solicito avaliação do Sr. Ismael Rodrigues, 72 anos, com diagnóstico recente de Saos
acentuado para ajuste de Cpap.

Atenciosamente.



Av Nove de Julho, 520 - sala 26, 2º Andar Vila Adyanna -

Centro médico Dr. Nelson D'Avila CEP 12243-000 -

São José dos Campos.

Telefone: (12) 3941 - 1888

Comercial: pcrdecarvalho13@gmail.com / Pessoal: pcrdecarvalho@uol.com.br